

Soins infirmiers dans les pathologies tropicales

Diapositive 1

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES

TROPICALES

UNITE PEDAGOGIQUE DE MEDECINE

Maitre Bernard ZOH, Formateur Santé et Travail Social

Diapositive 2

BILHARZIOSES

(SYN.

SCHISTOSOMIASES-SCHISTOSOMOSES)

DEFINITION

Les

bilharzioses sont des affections parasitaires dues à des vers plats, appelés bilharzies ou schistosomes.

Ce

sont des

trématodes

hématophages à

sexes séparés

,

vivant dans le système circulatoire.

Diapositive 3

HISTORIQUE

L'existence de

la

bilharziose est établie par la découverte

d'œufs calcifiés

de

S.

Haematobium

chez une

momie Egyptienne de la XX

ème

dynastie.

Au

moyen-âge, les médecins arabes parlent de « pissement de sang » des caravaniers revenant de Tombouctou.

Des

hématuries sont également signalées par les chirurgiens qui accompagnent Bonaparte en Egypte.

Au

17

ème

siècle,

le

Schistosoma

Mansoni

est transféré vers

les colonies espagnoles et portugaises d'Amérique

à partir de la

traite des

noirs.

Diapositive 4

HISTORIQUE

(SUITE)

En 1852, Théodore

Bilharz

découvre et décrit le

Schistosoma

Haematobium

.

En

1904,

Manson

décrit les œufs de le

Schistosoma

Mansoni

tandis que Katsura-da, au Japon découvre

S.

Japonicum

.

Enfin

, en 1934,

Fisher identifie

le

Schistosoma

Intercalatum

.

S.

Mekongi

est isolé au Laos en 1978.

Diapositive 5

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La

B. à

S.

Haematobium

sévit principalement dans

la vallée du Nil,

en Afrique

de l'Ouest et du

Sud

ainsi qu'au Maghreb avec d'autres foyers au

Yémen au Moyen Orient et en Inde.

La

B. à

S.

Mansoni

est

répandue en

Egypte

au Brésil,

au Venezuela et dans les

Antilles

La

B. à

S.

Intercalatum

est uniquement

africaine et sévit

essentiellement au Gabon, a

u

Congo en RDC en RCA et en Angola.

La bilharziose à

Schistosoma

Japonicum

sévit en Chine

, Corée

, au Japon et aux philippines.

Diapositive 6

AGENTS PATHOGÈNES

5

espèces sont pathogènes pour l'homme :

Schistosoma

Haematobium

est

l'agen

t

pathogène

de la bilharziose uro-génitale ;

Schistosoma

Mansoni

est responsable d'une bilharziose intestinale et parfois hépatosplénique ;

Schistosoma

Japonicum

et

S.

Mekongi

déterminent une redoutable bilharziose intestinale avec complications hépatiques ;

Schistosoma

Intercalatum

provoque une bilharziose rectale et génitale.

Diapositive 7

Réservoir de

germes et Hôtes

Intermédiaires (HI)

L'homme

malade ou non et certains animaux

(sauvages ou domestiques comme

les chiens, les chats, les

porcs

)

constituent les réservoirs de germes

.

Les Hôtes Intermédiaires

indispensables à l'évolution et à la propagation

de la maladie

sont des mollusques d'eau douce

spécifiques à chaque agent pathogène

:

Agents pathogènes

Hôtes Intermédiaires

S.

Haematobium

&

S.

Intercalatum

le

Bullin

S.

Manson

Le planorbe

S.

Japonicum

L'

onchomelania

S.

Mekongi

Lithoglyphopsis aperta

.

Diapositive 8

FACTEURS FAVORISANT

Certaines

professions multiplient le risque de contamination:

les

pêcheurs, les cultivateurs, les riziculteurs et les ouvriers entretenant les canaux d'irrigation

Les

femmes constamment au marigot pour leurs besoins ménagères sont un peu plus fréquemment atteintes que les hommes.

Les enfants

qui barbotent

dans

l'eau,

notamment aux heures

chaudes

sont

les

principaux responsables de l'infestation des mollusques

.

L'absence

d'hygiène fécale et urinaire favorisent évidemment l'endémie

Bilharzienne

.

L'extension des

cultures irriguées, les grands lacs de retenue des barrages hydro-électriques multiplient

les gîtes

des mollusques.

Diapositive 9

MODE DE CONTAMINATION / CYCLE PARASITAIRE

Les œufs de bilharzies rejetés dans le milieu extérieur avec les selles ou les urines vont éclore dans l'eau douce, si les conditions favorables sont réunies (température de 25 à 30°C, ensoleillement, PH neutre).

Ils libèrent le miracidium qui va nager à la recherche de son

Hôte Intermédiaire

spécifique.

Celui-ci

après avoir pénétré dans le mollusque,

bourgeonne et donne

des sporocystes

(le miracidium ne survit pas dans l'eau au-delà de 48 H).

Diapositive 10

MODE DE CONTAMINATION / CYCLE

PARASITAIRE (

suite

)

La suite du développement s'effectue dans

l'hépatopancréas du

mollusque

et aboutit à la formation des

furcocecaires

, larves à queue fourchue.

Celles-ci s'échappent du mollusque pour passer dans l'eau avant de pénétrer chez l'hôte définitif par la peau.

La

durée totale du cycle chez le mollusque est d'un mois

.

Diapositive 11

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA SYMPTOMATOLOGIE DE LA BILHARZIOSE

La première phase

appelée

P.

de pénétration ou

P. initiale

ou encore P. d'incubation

correspond

à la pénétration transcutanée des

furcocecaires

, c'est la

dermatite

cercarienne

le plus souvent discrète, voire inapparente

.

Diapositive 12

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA SYMPTOMATOLOGIE DE LA BILHARZIOSE

La seconde phase appelée phase d'invasion est contemporaine de la migration et des transformations de la Schistosomule

. Elle correspond aux réactions de l'organisme mis en contact avec les substances antigéniques et toxiques des vers.

Six

(06) semaines après l'incubation, l'on observe :des phénomènes allergies avec de la fièvre, des sueurs, et des céphalées. On peut noter également des

arthralgies

, des

myalgies

, de la toux, de la

dyspnée

et de la diarrhée.

Diapositive 13

BILHARZIOSE À SCHISTOSOMA HAEMATOBIIUM

Phase d'état

Le

signe évocateur est

l'hématurie macroscopique

avec des caractéristiques particulières : Il s'agit d'une

hématurie terminale

, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

Les signes d'une

cystite

: dysurie,

pollakiurie

, des douleurs sus-pelviennes,

exacerbées

par la miction obligent parfois le malade à se courber en deux.

Diapositive 14

BILHARZIOSE À SCHISTOSOMA MANSONI

La

phase d'état est dominée par les manifestations intestinales et hépatospléniques.

Trois (03) mois après un bain infestant, le patient présente:

Des

selles

molles ou franchement liquides, parfois glaireuses et sanguinolentes

,

voire dysentériques

;

Un

gros

foie, ferme, lisse et sensible

et une

rate également

augmentée de volume

avec un

état général

habituellement

conservé.

Diapositive 15

BILHARZIOSE À SCHISTOSOMA JAPONICUM & B. À .S. MEKONGI

La

période d'état

de la

Bilharziose à

Schistosoma

Japonicum

est

dominée par

l'atteinte hépatosplénique

.

Celle-ci

est précoce et rapidement grave:

à l'hépatosplénomégalie s'ajoute souvent un ictère

, des hémorragies digestives par

hypertension

portale, de l'ascite, des œdèmes, des phénomènes

d'hypersplénisme

.

Parallèlement, on note une altération de l'état général : amaigrissement, fièvre, anémie.

Diapositive 16

BILHARZIOSE À SCHISTOSOMA INTERCALATUM

A

la période d'état

, la symptomatologie est dominée par les manifestations rectales à type de diarrhée

souvent

glairo

-sanglante, de

douleurs rectales

, de coliques, de

ténésmes

(tensions douloureuses)

et

de

prolapsus.

Diapositive 17

DIAGNOSTIC

Il se fait par :

la

découverte des œufs de bilharzies

dans les selles et les urines ou dans le grattage des biopsies rectales.

la mise en

évidence d'une hyper éosinophilie sanguine

obéissant aux lois de

Lavier

(c'est-à-dire élevé à

la

massive au début de la maladie, régressive par la suite et persistant à des taux modérés.

Diapositive 18

COMPLICATIONS

Elles sont nombreuses et vont des plus simples aux plus complexes:

Vésicales

: surinfection, pyurie,

dystasie

du col, rarement

dégénérescence

épithéliomateuse

;

Urétrales

: envahissement du bas uretère, sténose ou incontinence du méat ;

Rénales

: néphrite ascendante ou hydronéphrose, mort du rein ;

Génitales

:

épididymite, cervicite, métrite, annexite, tumeur du vagin.

Diapositive 19

TRAITEMENTS

Praziquantel

(

BILTRICIDE

)

en

comprimé

de

600 mg

à la

p

osologie de 40

mg/kg

en

01 ou 02 prises en une seule

cure.

N.B

: Très actif sur les vers femelles et les

schistosomules

de moins de 15 jours, et les 5 bilharzioses humaines

.

PROPHYLAXIE

Elle repose sur la communication pour le changement de

comportement,

assainissement du milieu,

a

pprovisionnement

des zones rurales en eau potable, interdiction des baignades dans les cours d'eaux et

marigots,

p

ort

de bottes aux pêcheurs, aux cultivateurs, aux riziculteurs, aux ouvriers travaillant dans les canaux d'irrigation.

Diapositive 20

SERPENTS ET MORSURES DE SERPENTS

les serpents provoquent chaque année environ
500.000 morsures pour 40.000 décès

Les serpents sont répandus, dans le monde
entier et composés de
2500

espèces dont

7% seulement sont dangereux pour l'homme

On les regroupe selon la forme de leur appareil
venimeux

Aglyphes

(couleuvres, boa, python) : absence de crochets.

Diapositive 21

Opisthoglyphes

:

possèdent des crochets de chaque

coté

du maxillaire postéro-supérieur (difficilement accessibles et donc peu dangereux pour l'homme

).

Protéroglyphes

:

ont des crochets fixés sur le maxillaire antéro-supérieur, ils sont marins ou terrestres.

Solénoglyphes:

possèdent des crochets mobiles, relevés en avant au moment de la morsure, situés sur le maxillaire antéro-supérieur. Ils se composent de vipéridés et de colubridés.

Les Protéroglyphes et les Solénoglyphes sont les groupes les plus

présents

en Afrique en général, et en Côte d'ivoire en particulier

Diapositive 22

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 23

SOLENOGLYPHE

Diapositive 24

VENIN PATHOLOGIE

II

se présente comme un liquide jaunâtre et huileux, à l'origine il est sécrété par les glandes salivaires du serpent et sert à la digestion de l'animal.

Mais selon les circonstances, il peut s'agir d'une arme destinée à l'attaque ou d'un signe de défense.

Le venin agit de deux façons selon les catégories de serpent : le venin des élapidés (Naja) est neurotoxique entraînant les paralysies généralisées; le venin des vipéridés est hémolytique et nécrosant entraînant des troubles de la coagulation.

Diapositive 25

Morsure

par les élapidés

Signes locaux marqués par:

Des

douleurs

au point de

morsures

,

tremblements

musculaires

à type de

crampes

,

traces

de

crochets

Signes généraux

une lassitude angoissante et

invincible,

des frissons,

une

soif intense avec sensation de gorge

brûlante,

une

déglutition

difficile,

un ptôsis (chute de la paupière supérieur),

des

troubles

sphinctériens,

une

paralysie des muscles

respiratoires. Sans

traitement le

sujet

meurt dans

les six

(06)

heures qui suivent

,

dans

80%

des cas.

Diapositive 26

MORSURES PAR VIPÉRIDÉS

Signes

locaux marqués par:

Des douleurs

intenses au point de
morsure

,

des

traces de crochets sous forme
d'éraflures

et

des œdèmes

du membre mordu avec

ecchymose.

Signes

généraux

une

hypotension avec tachycardie et angoisse

Des vomissements/diarrhées avec une hypersudation

Si le sujet n'est pas traité dans les six

(06)

heures qui suivent, la mort survient dans

30%

des cas.

Diapositive 27

COMPLICATIONS

Les complications Immédiates

sont

constituées par les signes cliniques généraux quel que soit le type de serpent

.

Tardives

Les

élapidés

une dysphonie due à la paralysie de la langue

une

suffocation due à la paralysie du pharynx

une sialorrhée

Les

vipéridés

Des surinfections,

des

nécroses sous-cutanées et cutanées,

des

hémorragies

internes

des

épistaxis

Diapositive 28

TRAITEMENT

Principes

éviter la diffusion du venin,
neutraliser le venin,
éviter les réactions généralisées,
éviter les complications

Diapositive 29

Rôle de l'infirmier devant une morsure de serpent

Allonger le sujet mordu et le laisser au repos;

le

Calmer et désinfecter le point de

morsure et faire un bandage au niveau de la lésion;

Injecter 10 à 20 ml de gluconate de calcium en I.V lente;

Instaurer une corticothérapie;

Si le serpent a été identifié, injecter un sérum antivenimeux monovalent pour neutraliser le venin ;

Diapositive 30

Rôle de l'infirmier devant une morsure de serpent

Si le serpent n'a pas été identifié, injecter en S/C un sérum antivenimeux polyvalent ;

Cette injection se fait selon la technique de BESREDKA

Prévenir les infections par une antibiothérapie

;

Si le sujet n'est pas vacciné, faire un S.A.T. pour prévenir un tétanos

.

NB

:

Dans la mesure du possible, il faut éviter de faire marcher le sujet mordu.

La pause du garrot au-dessus et en dessous de la plaie est
déconseillée:

le

garrot ne doit pas empêcher la circulation
artérielle.

Diapositive 31

PATHOLOGIE DUE AU SERPENT CRACHEUR

PATHOLOGIE DUE AU SERPENT CRACHEUR

Le serpent projette son venin à distance choisissant une cible brillante. Les yeux

sont

le plus souvent

atteints.

Ce qui provoque

une

kérato

-conjonctivite

ulcérante

.

Le traitement repose sur :

Le lavage immédiat des yeux par du sérum salé isotonique,

L'instillation de

collyre mydriatique et pommade antibiotique,

ET

un pansement occlusif

Diapositive 32

TREPONEMATOSES

Diapositive 33

TREPONEMATOSES

Définition

:

Les

tréponématoses sont un groupe

d'infections bactériennes causées

par des tréponèmes appartenant à la famille des treponemaceae et du genre des treponema

.

Les tréponèmes causent essentiellement quatre (4) maladies qui sont: la syphilis endémique vénérienne;

le pian, le

bejel

;

la pinta ou carate.

Diapositive 34

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 35

LA SYPHILIS VENERIENNE

DEFINITION

:

C'est

une infection chronique causée par le
tréponème

pallidum, transmise par contact sexuel et évoluant par phases successives entrecoupées de périodes de latence.

Le réservoir de germes est constitué par les adultes des deux sexes en période d'activité sexuelle et plus spécialement les prostituées et les homosexuels de sexe masculin.

La transmission s'effectue en général au cours des rapports sexuels non protégés et exceptionnellement par l'intermédiaire du cordon ombilical et enfin à l'occasion d'une transfusion sanguine.

Diapositive 36

SYMPTOMATOLOGIE

L'incubation dure

3 semaines

environ et la symptomatologie évolue
en 3

phases:

Stade primaire ou syphilis primaire

Ce stade correspond

à l'invasion et à la dissémination du tréponème

.

Il se caractérise par un chancre génital ou

anal

à type d'ulcération

superficielle, unique, indolore, propre, abords nets, reposant sur une base indurée

.

Il s'accompagne d'adénopathies inguinales fermes, indolores, et qui guérit spontanément en 2 à 6 semaines sans laisser de cicatrices.

Diapositive 37

Stade secondaire ou syphilis secondaire

La syphilis secondaire est très contagieuse

. Elle

est échelonnée du 2

ème

mois aux 3 ou 4

ème

mois de la

syphilis.

Elle est marquée

par les signes cliniques regroupés en syndromes :

Syndrome pseudo grippal avec céphalées persistantes, larmoiement, écoulement nasal, pharyngite, arthralgies, fébricule, asthénie.

Une poly adénopathie ferme, indolore, étendu à toutes les aires ganglionnaires.

Des éruptions cutanées variées

.

Diapositive 38

stade

secondaire

Diapositive 39

La roséole faite de macules de

3

à 10 cm de diamètres, non prurigineuse, abords flous, séparées par des intervalles de peau saine, de couleur rose pâle

.

Elle disparaît spontanément en 1 ou 2 mois sans pigmentation, ni desquamation c'est la Syphilis secondaire de 1

ère

floraison

.

Diapositive 40

La syphilis

papulo

-squameuse faite d'éléments rouges sombres, saillants, couverts ou entourés de fines squames généralement non prurigineuse disséminée sur la peau y compris dans les paumes des mains et plantes des pieds.

C'est

la seconde floraison de la syphilis secondaire.

Diapositive 41

Stade tertiaire ou syphilis tertiaire

Il

correspond à l'apparition des lésions localisées et destructrices

,

il s'agit de l'atteinte du cœur et des

vaisseaux, de

l'atteinte du système nerveux central entraînant soit une détérioration des facultés intellectuelles,

Une altération

de la sensibilité

et une

ataxie

locomotrice

On peut noter

des lésions destructrices appelées gomme qui peuvent siéger dans

le tissu

sous-cutané, les os, les

viscères ou au

niveau de la face entraînent la destruction de la cloison nasale :

c'est le

gangosa

.

Diapositive 42

GANGOSA

Diapositive 43

DIAGNOSTIC

Le diagnostic repose sur la mise en évidence des tréponèmes par l'examen microscopique directe sur fond noir ou la lecture de

vago

.

Diapositive 44

Syphilis primaire et secondaire

Benzathine

pénicilline g (

extencilline

)

2,4 millions,

soit

1,2 million dans

chaque fesse à renouveler 1 semaine plus tard.

En cas d'allergie confirmée à la pénicilline: prescrire une cure de 15 jours de cyclines (tétracycline) :

2 g/j

(

Doxycycline

) : 200 mg/j

Syphilis tertiaire

Benzathine

pénicilline

2,4 millions :

1

inj

de

2,4

millions

/

semaine pendant trois (3) semaines

.

Diapositive 45

PIAN

DEFINITION

C'est une maladie contagieuse endémique non vénérienne, non congénitale due au *Treponema perten*

.

Il est caractérisé

par des lésions cutanées à surface granuleuse.

Diapositive 46

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 47

EPIDEMIOLOGIE

Le pian sévit principalement dans les régions tropicales et humides d'Afrique, d'Amérique Centrale et du Sud, de l'Asie du Sud-est.

L'agent pathogène est le
treponemaperten

.

Le
réservoir de germes est constitué par les
enfants malades
de 2 à 15 ans et les cas latents.

La transmission

est directe

par contact d'une lésion infectée avec une effraction cutanée ou muqueuse,

Diapositive 48

SYMPTOMATOLOGIE

Le pian est la plus

floride

et la plus mutilante des tréponématoses

endémiques.

Après

une incubation de 3 à 4 semaines, le pian évolue en trois phases : phase primaire et secondaire des accidents récents, et phase tertiaire des accidents tardifs

.

Diapositive 49

Phase primaire ou pian précoce

Elle est marquée par

l'apparition d'un chancre

pianique

, situé le plus souvent au niveau des membres inférieurs

et

parfois au niveau

d'une plaie

pré-existante

; et exceptionnellement au niveau des organes génitaux externes

.

Diapositive 50

Le chancre

pianique

est une ulcération de taille variable (jusqu'à 5 cm), prurigineuse, croûteuse, reposant sur une base non indurée.

Il s'accompagne habituellement d'adénopathies satellites.

Spontanément, le chancre

pianique

peut guérir en laissant une cicatrice

achromique(sans couleur)

ou au contraire se transformer en un volumineux

pianomes

et entouré de plus petits: c'est «

la maman-pian»

.

Diapositive 51

Phase secondaire

Trois (03) semaines après le chancre, apparaissent des pianomes

cutanés

végétantes

, sphériques, parfois prurigineuses.

Ces

pianomes

cutanés, parfois multiples, sont répandus sur toute la surface du corps. A la main ou aux pieds surtout chez les enfants marchant pieds nus, le «pian crabe» est fissuré et douloureux

.

Les lésions muqueuses (lèvres, joues, langue, périnée, prépuce) sont inconstantes.

Diapositive 52

Survenant isolément, s'associant ou succédant aux
pianomes

, les

pianides

sont des lésions sèches, extrêmement polymorphes, papuleuses, squameuses, carcinées ou
serpigineuses

.

On peut observer une atteinte osseuse: ostéites des phalanges, des doigts, (polydactylie),
hypertrophie des os propres du nez, la déformation du tibia en « lame de sabre». Ces atteintes
évoluent par poussées pendant quelques mois, mais finissent généralement par guérir.

Diapositive 53

Phase tertiaire

C'est celle des accidents tardifs, apparaissant après plusieurs années

:

les ostéites et périostites douloureuses et invalidantes avec des lacunes médullaires et un épaissement de la corticale, avec une propagation éventuelle vers les articulations, voire même vers les parties molles,

une pharyngite ulcéreuse et mutilante pouvant aboutir à la destruction totale du massif facial (gangosa

),

enfin des manifestations cutanées tubercule-ulcéreuse ou serpigneuses et des leucomelanodermies

.

Diapositive 54

Diagnostic différentiel

Impétigo:

petits boutons contenant du pus.

Gale:

papule cutanée avec prurits intenses et qui siègent dans les espaces interdigitaux.

Verrues plantaires:

lésions planes, douloureuses siégeant à la plante du pied.

Lèpre:

présentant des lésions anesthésiques.

Diapositive 55

Diagnostic positif

le diagnostic est affirmé par la découverte des tréponèmes, mobiles, au microscope à fond noir dans les prélèvements d'ulcérations ou de pianomes

.

la sérologie est positive (BW ; VDRL) dans la phase II secondaire, l'examen

histopathologique

montre des infiltrats granulomateux à prédominance plasmocytaire dans les lésions récentes et histiocytaires dans les lésions tardives

Diapositive 56

TRAITEMENT

Retarpen

: 2 millions 4

Adulte:

1 million 2 à 2 millions 4 en une seule injection selon la périodicité de l'atteinte.

Enfants

:

600 000

à

1

million

2

en une seule injection selon la périodicité de l'atteinte.

Tétracycline:

2 g/j en 4 prises pendant 15 jours.

Diapositive 57

PROPHYLAXIE

Elle est basée sur les campagnes de masse de pénicillothérapie.

L'OMS conseille les schémas thérapeutiques suivants dans les campagnes de masse.

- En zone de forte prévalence > 10 % :

Retarpen

:

Adulte : 1 million

2

Enfants

(-10 ans) 600 000 UI

En zone de prévalence moyenne 5 à 10 % : traitement des cas cliniques ainsi que des sujets contacts et des enfants de moins de 15 ans.

Zone de faible prévalence < 5 % : traitement des cas cliniques et des sujets contacts.

Diapositive 58

SYNDROMES DYSENTERIQUES

Diapositive 59

SYNDROMES DYSENTERIQUES

Les

syndromes dysentériques font penser à toutes les diarrhées

d'origine intestinale faite d'évacuation de selles liquides souvent glaireuses et sanglantes.

Ces diarrhées s'accompagnent de

douleurs abdominales traduisant une irritation du rectum et entraînant une déshydratation rapide

.

Les germes responsables sont soit des bactéries (shigelles

) ; des parasites (

lamblia

ou giardia, amibes).

Diapositive 60

SHIGELLOSE OU DYSENTERIE BACILLAIRE

Définition et Épidémiologie

C'est une

recto-colite provoquée

par des bactéries du genre

shigella

(

shigelles

)

et

touchant les intestins

.

Shigella

dysenteria

ou bacille de SHIGA,

Shigella

flexnerie

ou bacille de FLEXNER

Shigella

boydii

et

Shigella

sonnei

constituent les principaux agents pathogènes des

Shigelloses

.

Diapositive 61

SHIGUELLE/ SHIGULLA

Diapositive 62

Les hommes malades et les porteurs sains sont les réservoirs de germes.

Dans leur ensemble, les

Shigelloses

séviennent à l'état endémique en milieu tropical, avec recrudescence saisonnières, notamment à la saison des pluies.

La transmission se fait de façon directe par

manuportage

(maladie des mains sales) ou indirecte (par l'eau et l'alimentation).

Diapositive 63

Physiopathologie

Après ingestion des

shigelles

, ces germes évoluent vers les intestins où ils se multiplient et libèrent une toxine, qui va entraîner une sécrétion d'eau et d'électrolytes.

Ces

germes vont ensuite

proliférer davantage

et atteindre le colon où ils vont se multiplier et envahir toutes les cellules qu'ils détruisent entraînant ainsi une inflammation importante de la muqueuse et du colon.

Les tissus ainsi détruits vont se détacher peu à peu avec le flux du transit intestinal et laisser des ulcères superficiels.

Diapositive 64

Symptomatologie

Incubation

Après

une

incubation de 2 à 5 jours, l'on observe:

Des douleurs

abdominales plus ou moins importantes

une fièvre

des nausées

des vomissements

des frissons

Diapositive 65

Période d'état

Elle est caractérisée par

:

Des douleurs

abdominales intenses, avec épreintes (coliques violentes) et des ténesmes.

Une diarrhée

fécale faite de glaire-muco-sanguinolente, avec une moyenne pouvant aller jusqu'à 10 selles par jour et parfois plus.

Des vomissement

avec pertes hydro-électrolytiques importantes entraînant une déshydratation et une chute tensionnelle

.

Diapositive 66

Diagnostic et complications

Diagnostic

Le diagnostic repose sur la mise en évidence des

Shigellas

dans les selles

.

Evolution

Sans traitement, la mortalité est de 25% chez les enfants surtout. Mais sous l'effet du traitement avec une réhydratation précoce, l'évolution est favorable dans 100% des cas

.

Diapositive 67

Complications

une

déshydratation

une hémorragie digestive

une péritonite

une anémie chez l'enfant

Diapositive 68

Traitement

L'objectifs

du

traitement est de

maintenir

l'équilibre

hydro électrolytique et de limiter

la propagation de la

maladie. Il repose sur:

Le repos

au lit

Une alimentation

adéquate

La correction des

troubles hydro-électrolytiques par perfusion.

Instauration d'une

antibiothérapie

à base de

peni

G ou de cycline pendant au moins une semaine

Diapositive 69

Prophylaxie

Adopter une bonne hygiène individuelle en insistant sur le lavage des mains avant les repas et après les défécations ;

Traiter tous les cas déclarés ;

Instituer une bonne hygiène collective notamment par la surveillance des cours d'eau et la manipulation des aliments ;

Laver les fruits avant de les consommer ;

Servir toujours des aliments cuits et chauds en zone d'endémie.

Diapositive 70

GIARDIASE OU LAMBLIASE

Définition

La

giardiasse

est une parasitose de l'intestin grêle due à un protozoaire flagelle .

Souvent bien

tolérée, voire

et asymptomatique, elle peut

engendrer des troubles digestifs sévères chez l'enfant

.

L'agent pathogène de la

giardiasse

intestinale

se présente sous deux formes :

Diapositive 71

giardia

intestinalis

Diapositive 72

La forme végétative

Les

trophozoïdes se multiplient par scissiparité dans le duodénum et le jéjunum initial où vivent plaqués à la surface de la muqueuse, sans pénétrer à l'intérieur des cellules.

Diapositive 73

La forme kystique

Les

kystes ovoïdes sont éliminés avec les selles et peuvent survivre plusieurs semaines dans le milieu extérieur

et 3

mois dans

l'eau. C'est

la forme de dissémination du parasite.

L'homme se contamine en ingérant les kystes murs avec de l'eau de boisson, des aliments crus ou à la faveur des mains sales.

Diapositive 74

Symptomatologie

La

giardiase

reste asymptomatique ou provoque des troubles digestifs variés.

Période

de début

Le début est habituellement progressif, parfois brutal évoquant une gastro-entérite aiguë et associe une anorexie, des nausées, des douleurs abdominales

.

Diapositive 75

Période d'état

Diarrhées

faites de 5 à 10 exonérations par jour, surtout matinales et postprandiales

.

Elle sont faites de selles pâteuses ou liquides, jaunâtres ou claires, parfois mousseuses ou graisseuses, exceptionnellement sanglantes.

Elle

peut-être permanente ou intermittente

et

peut aussi alterner avec de la constipation et accompagnée de brûlures anales lors de la défécation.

Les douleurs épigastriques et les troubles

dyspeptiques variés : nausées, anorexie, ballonnement abdominale,

flatulences peuvent s'ajouter à ce tableau

Diapositive 76

Diagnostic

L'examen coprologique est en règle suffisant, car il permet de mettre en évidence les kystes et les trophozoites

mobiles (formes végétatives).

En cas de forte suspicion avec examen de selles négatives, on peut rechercher les parasites par tubage duodéal.

Enfin on peut faire une biopsie du grêle. Elle permet de mettre en évidence les parasites à la surface de la muqueuse ou dans les espaces

intervillositaires

.

Diapositive 77

Complications

Il faut surtout redouter un syndrome de malabsorption intestinale chez l'enfant.

Cliniquement, les selles sont abondantes, malodorantes, graisseuses, on note également un amaigrissement considérable.

Biologiquement, on peut noter des troubles de l'absorption des graisses : (stéatorrhée), des protides (créâtorrhée).

Diapositive 78

Traitement

Métronidazole

(FLAGYL)

:

Adulte

: 1 à 3

cp

/j

pdt

7 jours à renouveler 10 à 15 jours plus tard.

Enfant: 10 mg/kg/j

pdt

7 jours à renouveler 10 à 15 jours plus

tard.

Tinidazole

(FASIGYNE

):

Omidazole

(TIBERAL

):

Secnidazole

(FLAGENTYL)

Adulte: 2g en une prise unique à renouveler 20 jours après

Enfant: 50 mg 1 kg en une prise unique à renouveler 20 jours plus tard.

Diapositive 79

Prophylaxie

Renforcer les mesures d'hygiène alimentaire et les mesures d'hygiène générale ;

Dépister et traiter tous les sujets parasités pour éviter les ré-infestations de l'entourage.

Diapositive 80

AMIBIASE

L'amibiase est une
protozoose

due

à

l'

Entamoeba

histolytica

hébergé par l'organisme humain avec ou sans manifestation
clinique.

l'amibiase est une des parasitoses les plus répandues dans le monde.

Elle

est responsable de manifestations coliques et hépatiques.

Diapositive 81

AMIBE

Diapositive 82

EPIDEMIOLOGIE

L'agent pathogène est un protozoaire: l'

entamoeba

histolytica

qui se présente sous trois formes:

deux formes végétatives:

forme végétative minuta ou

entamoeba

histolytica

minuta

qui est

un saprophyte

du colon

, non hématophage.

forme végétative

histolytica

ou

Entamoeba

Histolytica

(EHH

)

qui est la forme

pathogène, hématophage.

Diapositive 83

une forme Kystique

d'

Entamoeba

Histolytica

(KEH)est la forme de résistance dans le milieu extérieur (survie 15 jours dans l'eau à 25°C).

Elle est infectieuse et peut être détruite par la cuisson.

L'homme est l'unique réservoir du parasite (porteur sain qui n'a jamais eu les signes cliniques ou les convalescents d'une amibiase aigue.

La transmission est interhumaine directe (mains sales) ou indirecte (eau de boisson et aliments crus souillés-mouches).

Diapositive 84

CYCLE PARASITAIRE

Le cycle évolutif de l'amibiase comprend

2 étapes distinctes

.

Le cycle non pathogène est

le

plus courant. Le sujet avale des kystes avec des crudités ou de l'eau. Ceux-ci, dans le tube digestif, se transforment en

amoebules

puis en forme minuta

.

Ces dernières se nourrissent de résidus

alimentaires,

se multiplient, puis s'enkystent et sont éliminées: kystes à 1, 2 ou 4 noyaux). Le sujet est asymptomatique, mais dissémine la maladie.

Diapositive 85

Le cycle pathogène débute par une transformation des formes minuta en formes histolytica

, sous

diverses influences (

altération de l'état général, agressions coliques). Les amibes devenues ainsi agressives, phagocytent des hématies, pénètrent dans la muqueuse colique en provoquant des abcès en « bouton de chemise », qui vont secondairement s'ouvrir par des ulcérations avec rupture des capillaires sanguins

.

Diapositive 86

Par ailleurs, le péristaltisme intestinal s'accélère et les cellules à mucus secrètent en abondance. Les amibes hématophages sont entraînées et éliminées avec les selles diarrhéiques. Certaines amibes gagnent soit par la contiguïté, soit par la circulation sanguine d'autres organes (foie, poumons, etc.).

Diapositive 87

FORMES CLINIQUES DE L'AMIBIASE

Signes

cliniques de la forme aiguë l'a
mibiase
intestinale

Le début est brusque et réalise un syndrome dysentérique aigu fait de 8 à 10 selles fécales, contenant des glaires, du pus et du sang (crachats dysentériques).

Il

s'accompagne de douleurs abdominales sur tout au niveau du cadre colique, d'épreintes et de ténésmes (contractures douloureuses du sphincter anal avec faux besoins).

Diapositive 88

traitement mis en œuvre rapidement, la guérison survient en quelques jours, sans séquelles. Mal traitée, des rechutes ou récidives sont fréquentes avec un risque de chronicité.

Signes cliniques de l

a

forme chronique

La forme chronique se manifeste par

des troubles du transit intestinal avec

alternance

de syndrome dysentérique et ou de constipation

.

Le diagnostic de l'amibiase

repose sur la mise en évidence des EHH dans les selles

fraîches ou dans certains cas à partir d'une rectoscopie ou une

rectosigmoïdoscopie

Diapositive 89

Traitement

Amoebicides

majeurs

Ce sont des

amoebicides

qui diffusent dans les tissus par voie sanguine et atteignent les EHH au sein même des tissus.

Métronidazole

(

Flagyl

):

Posologie

: Adulte: 1,5 à 2 g/24h réparties en 3 prises

pdt

5 à 10 jours

et enfant

: 40-50 mg/kg

pdt

7 jours

Les

autres imidazoles

:

Secnidazole

(

Flagentyl

)

Tinidazole

(

Fasigyne

)

Ornidazole

(

Tiberal

)

Diapositive 90

Amoebicides

d'appoint ou contact

Ils agissent sur les formes minuta et sur les kystes d'Eh, dans la lumière colique.

Difetarsone

(

Bemarsal

)

:

cp

500 mg

à la

Posologie

: 2 g/j: en 2 prises

pdt

10 j chez l'adulte

.

Les

antibiotiques ne sont utilisés que si une bactérie pathogène est isolée.

Diapositive 91

Prophylaxie

La prophylaxie individuelle s'appuie sur
la consommation

d'eau traitée par filtration ou ébullition, le lavage des fruits et légumes, le
lavage systématique

des mains avant les repas et après passage aux
toilettes

La

prophylaxie collective comprend le dépistage et le traitement des porteurs d'amibes, l'interdiction de
l'utilisation d'engrais humains, la construction et l'utilisation des latrines, la protection des aliments
contre les microbes.

Une éducation

sanitaire continue peut parvenir à intégrer ces mesures d'hygiène dans le comportement habituel
des populations vivant en zones d'endémie

Diapositive 92

Amibiase

hépatique

(amibiase suppurée

)

Signes cliniques

Phase de début

Le début est brusque et survient fréquemment sans expression clinique de l'amibiase intestinale qui est sa porte d'entrée plusieurs mois après la contamination.

Diapositive 93

Phase d'état:

une

fièvre 39°- 40°, accompagnée de douleurs

spontanée de

l'hypochondre

droit,

irradiant dans l'épaule droite, bloquant l'inspiration profonde qui la
majore.

Elle peut

être

provoquée

lors de la recherche prudente du signe de l'ébranlement. (Du tranchant de la main droite, on percute
l'autre main posée à plat sur le foie

)

A l'examen physique on a

une hépatomégalie et une altération de l'état général.

Diapositive 94

Diagnostic

L'hémogramme montre une hyper leucocytose à polynucléaires neutrophiles. (

L'amibiase ne donne jamais d'

hyperéosinophilie

).

La vitesse de sédimentation est supérieure à 50 mm à la 1

ère

heure et

Le taux

des enzymes hépatiques (phosphatases alcalines, transaminases) est inconstant et modérément élevé.

La radiographie du thorax montre une coupole surélevée, immobile, avec souvent un épanchement pleural du même côté.

Diapositive 95

Évolution et Traitement

Sous traitement,

l'évolution se

fait vers la guérison dans la très grande majorité des cas

.

Parfois surviennent des complications telles que:

ictère, par compression des voies biliaires,

rupture dans le péritoine, le péricarde, la plèvre ou le médiastin,

Extension progressive

pleuro-pulmonaire

progressive

.

En plus du traitement de l'amibiase colique, il faut faire un drainage chirurgical du contenu de l'abcès.

Diapositive 96

TRYPANOSOMIASES HUMAINES
AFRICAINES OU
MALADIE DU SOMMEIL

Diapositive 97

DEFINITION

Les

trypanosomiasés humaines africaines sont des affections parasitaires transmises à l'homme par la mouche tsé-tsé ou glossine, se caractérisant par une fièvre irrégulière, des adénopathies suivies par un syndrome

méningo-encéphalitique

.

Diapositive 98

MOUCHE TSE-TSE OU GLOSSINE

Diapositive 99

EPIDEMIOLOGIE

Endémiques dans 36 pays africains, ces affections concernent 50 millions d'êtres humains exposés au risque de contamination, mais 5 à 10 millions seulement sont maintenant sous surveillance régulière.

Deux formes sont décrites: Trypanosomiase

gambiense

et Trypanosomiase rhodésienne

Diapositive 100

Trypanosomiase à
trypanosoma
gambiense

Elle sévit en Afrique occidentale et centrale intertropicale.

Au Nigeria, 13 millions d'hommes au moins sont exposés à l'affection, notamment en zone
biafraise

.,

La maladie

sévit au Cameroun, au Congo, au Gabon, en R.C.A., en Guinée Equatoriale et au Tchad.

Ses agents vecteurs sont les mouches tsé-tsé,

vivant

dans les galeries forestières ; tous hématophages.

Diapositive 101

Trypanosomiase à
trypanosoma
rhodésien

Elle
s'étend depuis
l'est des grands des lacs et
jusqu'à
l'Océan indien, ceci du sud de l'Ethiopie au Mozambique.

La
trypanosomiase
Rhodesiense
est d'évolution plus rapide. Son agent pathogène est le
trypanosoma
rhodesien

.
Le réservoir de parasites est constitué de l'homme, des animaux sauvages (antilopes) et le bétail

.
Les agents vecteurs sont
les
glossines
qui vivent
dans les savanes boisées.

Diapositive 102

MODE DE CONTAMINATION / CYCLE BIOLOGIQUE

La glossine se contamine seulement lors

d'un

premier repas de sang en piquant un dormeur; elle ingère avec son sang des trypanosomes qui subissent chez elle un cycle complexe et apparaissent trois (03) semaines plus tard dans ses glandes salivaires sous forme méta cyclique

infestante

.

À l'occasion d'un nouveau repas sanguin, la glossine transmet l'affection en injectant sa salive virulente dans la plaie de piqûre.

Diapositive 103

Forme

typique

de

la

trypanosomiase

T.

gambiense

Incubation

Faisant suite à la piqûre

infestante

, l'incubation dure habituellement de 05 à 20 jours, parfois plusieurs années. La piqûre de la glossine passe souvent inaperçue au milieu de multiples agressions en milieu tropical.

Ailleurs,

elle provoque une réaction locale immédiate: le chancre d'inoculation ou

trypanome

, d'aspect

furonculoïde

, il est douloureux ou seulement prurigineux, s'accompagne parfois d'adénopathies satellites et persiste quelques jours.

Diapositive 104

Première période

: phase

lymphatico

-sanguine ou phase de généralisation

Cette première période

est dominée par :

Une fièvre

:

quasi

constante, habituellement modérée entre 38 et 38,5 degrés, anarchique rebelle aux antipyrétiques, aux antipaludiques, aux antibiotiques et aux

corticoïdes et

s'associe à une altération variable de l'état général.

Diapositive 105

Des adénopathies

: intéressent surtout les chaînes cervicales et sus claviculaires et plus rarement les chaînes axillaires ou Inguinales. Les ganglions sont modérément hypertrophiés (1 à 2 cm), mobiles, indolores élastiques, ils ne suppurent jamais.

une

hépatomégalie

modérée et inconstante.

des

signes cutanés

: apparition de

trypanides

qui siègent sur le

tronc

et

la racine des membres.

Diapositive 106

2

ème

période

: Phase de polarisation cérébrale ou phase
meningo

-e

ncéphalique

Apparition de

signes neurologiques variés:

Troubles sensitifs

:

ils sont précoces. L'hyperesthésie profonde, classique (signe de KERANDE) ;on observe également des paresthésies, des crampes musculaires, des douleurs radiculaires ou névralgiques ou des phénomènes d'anesthésie ou d'hyperesthésie en zone,

Troubles psychiatriques

:

modifications

du caractère du malade qui de jovial devient apathique ou de triste devient hilare, des troubles du sommeil plus tardifs, ils sont caractéristiques.

Diapositive 107

Au début, le rythme nycthéméral est seulement inversé la somnolence diurne contraste avec l'insomnie nocturne. Plus tard, le trypanosome entre dans un état d'hébétude permanent. La maladie du sommeil mérite alors vraiment son nom.

Troubles moteurs

: ils sont variés et rares : tremblements, crises convulsives.

des troubles

neuro-endocriniens

:

ils témoignent de l'atteinte de l'axe

diencéphalo

- hypophysaire entraînant des troubles de la régulation thermique et de la soif, une perte de la libido, une aménorrhées, une stérilité.

Diapositive 108

EVOLUTION

Sans traitement

, le malade s'achemine plus ou moins vite

vers la cachexie sommeilleuse terminale : inexpressif, indifférent, décharné, grabataire, il sombre dans le coma ou meurt emporté par une infection intercurrente.

Les trypanosomiasés traités

précocement(à

la phase

lymphatico

-sanguine)

sont de meilleurs pronostics.

Traitées, à

la phase

méningo-encéphalitique

, les résultats sont moins brillants: séquelles neuropsychiques, rechutes.

Diapositive 109

DIAGNOSTIC

POSITIF

et

TRAITEMENT

Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du parasite soit dans le suc de ponction ganglionnaire, soit dans le sang (goutte épaisse et frottis), soit enfin dans le liquide céphalorachidien

.

TRAITEMENT D'ATTAQUE

Réhydrater le

malade par des perfusions fréquentes avec des électrolytes ;

Administrer des

vermifuges pour corriger les troubles provoqués par les parasitoses

intestinales

Faire une

antibiothérapie (Amoxicilline) diffusible dans le L.C.R.

Diapositive 110

PROPHYLAXIE

Lutter contre

les glossines par l'utilisation des pièges et d'écrans en tissu imprégné d'insecticide, le débroussaillage des alentours des concessions, l'épandage aérien de DDT et la pulvérisation terrestre d'insecticide à grande échelle même dans les domiciles,

Dépister et

traiter les sujets

exposés

,

Lutter contre

le réservoir animal de parasites(des
antilopes)

Diapositive 111

PARASITOSSES
INTESTINALES

Diapositive 112

NEMATODOSES INTESTINALES

Les

nématodoses

intestinales sont des helminthiases liées à la présence dans l'intestin de l'homme de vers ronds ou nématodes.

Trois

d'entre elles ont une incidence notable en zone tropicale :

L'ascaridiose,

responsable de troubles digestifs parfois sévères

;

L'ankylostomiase

qui

détermine une spoliation sanguine grave chez l'enfant carence ou déjà anémique;

L'anguillulose

,

remarquable par sa ténacité.

Diapositive 113

ASCARIS

ANGUILLULE

ANKYLOSTOME

Diapositive 114

ASCARIDIOSE OU ASCARIDIASE

L'ascaridiose est une parasitose intestinale cosmopolite, spécifiquement humaine, d'origine essentiellement alimentaire (ingestion des légumes, de crudités, d'eau portant des œufs embryonnés

) due à un nématode :

l'ascaris

qui

est responsable de troubles parfois très graves chez l'enfant.

Diapositive 115

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 116

MODE

DE CONTAMINATION - CYCLE BIOLOGIQUE

La femelle émet de nombreux œufs à coque mamelonnée qui rejette

dans les selles, un embryon (larve
).

(1)

L'homme se contamine en ingérant cet œuf infestant.

(2)

La larve libérée au niveau de l'estomac, traverse la paroi intestinale

(3)

,
gagne le foie par la veine porte

(4)

,
puis le cœur droit et les poumons

(5)

.
Après effraction de la paroi alvéolaire pulmonaire, la larve remonte le long de l'arbre bronchique jusqu'au carrefour

aéro-digestif

(6)

,
elle est déglutie et parvient dans l'intestin où elle devient adulte

(7)

.
La durée de ce cycle est de 7 à 8 semaines.

Diapositive 117

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 118

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Les signes cliniques sont fonction de la migration larvaire.

Au

niveau pulmonaire

Les signes cliniques sont dominés par le syndrome de Loëffler

caractérisé par une fièvre, une toux, de la dyspnée asthmatiforme

avec expectoration pouvant contenir des éosinophiles.

Diapositive 119

Au niveau digestif

Les ascaris adultes sont responsables de troubles digestifs tels que : des coliques, de la diarrhée, une anorexie, des nausées, des vomissements de un ou plusieurs ascaris parfois.

Au niveau cérébral

On peut noter une agitation, une irritabilité, une terreur nocturne, il faut noter que ces signes sont très rares.

Diapositive 120

COMPLICATIONS

Elles

sont marquées par :

une occlusion intestinale due à la présence d'un ou de plusieurs vers en peloton.

un ictère par obstruction des canaux biliaires.

une péritonite par perforation intestinale.

une pancréatite aiguë par l'engagement de l'ascaris dans l'ampoule de Vater.

une appendicite par migration de l'ascaris dans l'appendice

.

Diapositive 121

DIAGNOSTIC

Le

diagnostic est évoqué par une

hyperéosinophilie

sanguine très élevée pouvant atteindre 50%.

La découverte d'œufs dans les selles (examen des selles), parfois le rejet d'un ver (par la bouche, le nez ou l'anus) donne la certitude.

Diapositive 122

TRAITEMENT

Traitement médical

Helmintox

à la

Posologie

: 10 mg/kg en une seule prise

Autres:

Zentel

,

Alben

,

combantrin

L'intervention chirurgicale d'urgence s'impose en cas de complications, d'occlusion, de péritonite, d'appendicite

Diapositive 123

PROPHYLAXIE

La

stérilisation des réservoirs de
parasites:

identification et traitement
de tous les porteurs d'ascaris.

L'hygiène

individuelle

lavage

des mains avant les repas,

lavage

des légumes et les fruits à

consommer crus,

consommation

de l'eau potable.

Diapositive 124

L'hygiène collective

La construction

et l'utilisation des latrines ou des fosses d'aisance,

La protection

des points d'eau

L'interdiction de

l'utilisation des

fèces

humains comme engrais pour les cultures maraichères.

Diapositive 125

ANKYLOSTOMIASE OU ANKYLOSTOMOSE

DEFINITION

L'ankylostomiase est une helminthiase fréquente en milieu tropical due

à la présence dans le duodénum de deux (02) vers nématodes:

ankyslostoma

duodénale et

Necator

americanus

responsables en cas d'infestation importante d'anémie grave parfois mortelle.

Diapositive 126

DESCRIPTION DES PARASITES

Deux ankylostomes spécifiquement humains;

Ankylostoma

Duodénaux (A.D.) et

Necator

Americanus

(N.A.).

Cylindriques, de couleur blanc rosé, ils mesurent 10 à 18 mm pour les femelles et 8 à 11mm pour les mâles.

Ils

sont caractérisés par leur capsule buccale armée.

Diapositive 127

Ils vivent enchâssés dans la muqueuse duodénale et se nourrissent de sang

.

Ils secrètent une enzyme anticoagulante qui prolonge le saignement.

Ils

sont très fréquents dans les régions chaudes et
humides

Ils ont

une durée de vie de 4 à 5 ans pour A.D. et 10 à 15 ans pour N.A.

Diapositive 128

MODE

DE CONTAMINATION-CYCLE BIOLOGIQUE

La femelle fécondée pond des œufs qui sont éliminés dans les selles.

Dans

le milieu

extérieur, l'œuf

mûrit et donne naissance en 24 heures à une larve

rhabditoïde

.

Cette

larve se transforme en moins de 24 heures en larve

strongyloïde

et 5 à 10 jours plus tard, en larve

strongyloïde

enkystée. Cette

dernière, mobile et résistante, surtout dans le sol humide ou

dans la

boue, est la larve

infestante

.

Diapositive 129

La larve

strongyloïde

enkystée traverse activement la peau (pied
nu, fesse)

en abandonnant son enveloppe par voie sanguine ou
lymphatique.

Elle parvient

au cœur et de là, passe dans l'artère pulmonaire jusque dans ses plus fines ramifications.

Elle quitte

la voie sanguine pour la voie aérienne

,

franchit la paroi alvéolaire, remonte

la bronchiole

au niveau des bronches et la trachée jusqu'au carrefour aéro-digestif qu'elle atteint au 4
eme

jour.

Diapositive 130

A la faveur de secousses de toux et de mouvements de déglutition, elle bascule dans le tube digestif (œsophage-estomac-duodénum-jéjunum) pour achever sa maturation (adulte).

Quarante (40) jours environ après la contamination, on peut mettre en évidence des œufs dans les selles.

Diapositive 131

ANKYLOSTOME

Diapositive 132

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Phase tissulaire ou période de migration larvaire

Discrète ou muette elle

est marquée par :

Des troubles

cutanés:

la traversée des larves

infestantes

réalisent la « gourme des mineurs

» qui est

un érythème papuleux, prurigineux, parfois compliqué de lésion de grattage.

Un catarrhe

des

gourmes

qui

une

simple irritation des voies

aéro-digestives supérieures

avec une toux surtout vespérale, expectoration muqueuse, dysphonie voire dysphagie.

Diapositive 133

Phase

endocavitaire

ou période de fixation digestive

La présence des vers adultes dans le

duodéno

-jéjunum n'engendre paradoxalement que peu de troubles digestifs mais, déterminé parfois une anémie sévère :

Troubles digestifs:

dominés essentiellement par une duodénite,

qui

se

traduit

par des douleurs épigastriques, des nausées, des vomissements, de l'anorexie ou une perversion du goût (géophagie), une diarrhée mousseuse et un amaigrissement important

.

Diapositive 134

Le Syndrome

anémique

résulte

de la spoliation sanguine par les ankylostomes. Son intensité dépend de l'espèce en cause (A. duodénal soustrait davantage de sang que le N.A), de l'intensité du parasitisme et de l'état nutritionnel du malade.

L'anémie

ankylostomienne

grave réalise un tableau original et se traduit par

la pâleur, des signes cardiovasculaires à type de dyspnée d'effort, de tachycardie, d'hypertension, d'œdèmes sous

cutanés

mous, indolores, prenant le godet, infiltrant souvent la face, les paupières notamment les membres Inférieurs et les organes génitaux,

des anomalies

unguéales : ongles souvent ramollis.

Diapositive 135

COMPLICATIONS et

DIAGNOSTIC

Anémie

Duodénite

DIAGNOSTIC

Penser à l'ankylostomiase devant toute anémie surtout en zone tropicale.

Il faut évaluer l'importance de l'anémie par un hémogramme et par la mise en évidence des œufs d'ankylostomes dans les selles.

Diapositive 136

TRAITEMENT

Traitement spécifique du parasite

Il consiste à déparasiter le porteur d'ankylostomes:

Combantrin

:

Posologie

: 20 mg/kg en 1 ou 2 prises pendant 2 à 3 jours

Zentel

:

Posologie

: 1

cp

en 1 prise unique.

Traitement

antianémique

Proposer un

régime riche en protéine animale

Médicaments

:

Féfol

: 1

cp

Fumafer

Transfusion:

envisager une transfusion sanguine dans les formes sévères.

Diapositive 137

PROPHYLAXIE

L'identification et le déparasitage systématique de tous les porteurs d'ankylostomes.

La lutte contre le péri-fécal

par la

construction et l'utilisation des latrines.

Le port de chaussure pour éviter les pénétrations des larves

strongyloïdes

enkystées enfouies dans le sol.

Diapositive 138

ANGUILLULOSE

OU STRONGYLOÏDOSE

L'anguillulose

est due au parasitisme duodénal d'un ver

rond appelé

Strongyloïde

stercoralis

. Parasitose intestinale mineure, elle peut dans certaines circonstances se transformer en une affection

généralisée au pronostic

sévère.

L'anguillule

est un

petit ver rond à peine visible à l'œil nu. Les femelles parthénogénétiques mesurent 2 à 3 mm de long et leur œsophage possède un seul renflement (forme

strongyloïde

) ; elles vivent profondément enchâssées dans la muqueuse duodénale de l'homme mais ne sont pas hématophages.

Diapositive 139

MODE DE CONTAMINATION-CYCLE BIOLOGIQUE

Les femelles parthénogénétiques pondent des œufs qui
éclorent
dans l'intestin.

Des

larves dites

rhabditoïdes

s'en

échappent. Celles-ci sont évacuées avec les selles dans le milieu extérieur.

Ces

larves

rhabditoïdes

dites

de première

génération

vont subir un cycle complexe en fonction de certaines conditions avec diverses évolutions.

Diapositive 140

CYCLE EXTERNE, ASEXUÉ-DIRECT

Les larves

rhabditoïdes

émises dans les elles se transforment directement dans la nature en larves

strongyloïdes

infestantes

.

L'homme se contamine par voie cutanée en marchant pieds nus dans la boue ou en se baignant dans les cours d'eau ou une piscine.

Après avoir franchi les téguments, les larves migrent par voie sanguine au niveau du cœur droit, puis des poumons ou elles changent de direction et remontent

bronchioles et

bronches, trachée, jusqu'au carrefour

aéro-digestif.

Elles sont

alors dégluties après avoir franchi le pylore, elles deviennent des femelles parthénogénétiques

.

Diapositive 141

CYCLE

EXTERNE, SEXUE, INDIRECT OU HETEROGONIQUE

les

larves

rhabditoïdes

se muent en adultes stercoraires

,

les femelles fécondées pondent des œufs donnant naissance à des larves

rhabditoïdes

de « 2

ème

génération »

les

larves se transforment à leur tour en larves

strongyloïdes

infestant l'homme par voie cutanée ;

il

se produit ainsi une multiplication parasitaire dans le milieu extérieur

. Les

stades ultérieurs du cycle sont identiques à ceux du

précédent

.

Diapositive 142

CYCLE INTERNE OU CYCLE D'AUTOREINFESTATION ENDOGENE

C'est un cycle court, avec transformation directe des larves

rhabditoïdes

en larves

strongyloïdes

dans l'intestin du

malade.

Les

larves

strongyloïdes

infestantes

vont traverser la paroi intestinale et suivre le parcours habituel.

Ceci

explique la longévité de l'affection qui peut dépasser 20 voire 30 ans, alors que la survie des femelles est relativement brève.

Diapositive 143

ANGUILLULOSE

Diapositive 144

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Elles se déroulent en trois phases

La phase d'invasion

est

caractérisée surtout par des manifestations cutanées, des allergies type urticaire et des manifestations pulmonaires tels que la dyspnée, la toux.

La

phase

de migration

est laryngée-pulmonaire, marquée par

une

toux avec expectoration riche en cellules éosinophiles, une dyspnée

asthmatiforme

et

un

catarrhe des voies aériennes

supérieures

Diapositive 145

Phase d'état

est

dominée

par

les signes digestifs :

Duodénite

faite de

douleurs siégeant au niveau de l'épigastre ou de l'hypocondre droit, parfois plus bas, variables en intensité, capricieuses, ni rythmées par les repas, ni périodiques dans l'année.

Troubles du transit à type de diarrhée ou d'alternance de diarrhée et de constipation.

Signes cutanés

sont

faits d'urticaire

banal et un

larvacurreus

(dermatite linéaire, rampante, entraînée, serpigineuse, érythémateuse,

) partant

de l'orifice anale, ou survenant en bande au niveau de l'aisselle ou du thorax.

Diapositive 146

ANGUILLULOSE DISSÉMINÉE OU MALIGNE

Elle est due à un emballement du cycle d'auto infestation interne et conduit à une augmentation massive des larves en circulation « hyper infection » puis à leur dissémination dans tout l'organisme (anguillulose disséminée).

Lors

de cette diffusion, les parasites entraînent avec eux des germes fécaux qui contribuent à la forte mortalité observée dans l'anguillulose maligne.

La gravité de cette forme justifie un traitement systématique, chez un sujet susceptible d'avoir été infesté, avant d'entreprendre une corticothérapie.

Diapositive 147

Diagnostic

Penser à l'anguillulose devant une

hyperéosinophilie

sanguine > 500

éosinophiles

/mm³ de sang: Cette

hyperéosinophilie

évolue en dents de

scie.

La

mise en évidence des larves

rhabditoïdes

dans les selles

fraîches.

Traitement:

Thiabendazole

(

Mintezol

)

à la posologie

: 50 mg/kg en dose unique 25 mg/kg pendant 3 jours, dose répétée

.

Albendazole

(

Zentel

)

à la

Posologie

: 15 mg/kg

Diapositive 148

OXYUROSE

DEFINITION

L'OXYUROSE EST UNE AFFECTION COSMOPOLITE BÉNIGNE STRICTEMENT HUMAINE, DUE À LA PRÉSENCE DANS LE RECTUM ET DE L'ANUS D'UN VER NÉMATODE: L'OXYURE OU ENTEROBIUS VERMICULARIS FRÉQUENTE CHEZ LES ENFANTS.

Diapositive 149

DESCRIPTION DU PARASITE

C'EST

UN PETIT VER ROND, TRÈS FIN COMME UN CHEVEU DE COULEUR BLANCHE, MESURE 8 À 13 MM DE LONG POUR LA FEMELLE ET 2 À 3 MM DE LONG POUR LE MÂLE. LE COUPLE VIT DANS LA RÉGION CAECO-APPENDICULAIRE FIXÉ À LA MUQUEUSE.

Diapositive 150

MODE DE CONTAMINATION-CYCLE BIOLOGIQUE

Les femelles fécondées migrent jusqu'au rectum et se fixent à la marge anale, elles y pondent des milliers d'œufs

embryonnés

, d'emblée infestant. Le malade répand ainsi autour de lui des milliers d'œufs et contamine son entourage, familial et scolaire. Lorsqu'ils sont ingérés, ces œufs libèrent dans l'estomac, une larve qui devient adulte dans l'iléon terminal en 3 semaines.

L'auto ré-infestation est fréquente chez l'enfant peu soucieux des règles d'hygiène: en cherchant à soulager son prurit anal, il souille ses mains d'œufs qu'il avale ensuite.

Diapositive 151

OXYURE

Diapositive 152

MANIFESTATIONS CLINIQUES

L'oxyurose est souvent latente. Le signe pathognomonique est le prurit anal, il est très intense, le plus souvent vespéral ou nocturne, responsable de surinfection.

Chez la petite fille, les femelles remontant jusqu'à la vulve sont responsables de vulvites ou de vulvo-vaginites.

Des troubles digestifs sont possibles, mais peu évocateurs : douleurs de la fosse iliaque droite, des troubles du transit, anorexie.

Quant aux signes nerveux et attribués à l'oxyurose (prurit nasal, grincement des dents, terreurs nocturnes, troubles du caractère «nervosité-

nuitabilité

» etc.) leur réalité n'est pas démontrée

.

Diapositive 153

DIAGNOSTIC

La preuve

parasitologique

est apportée soit:

Par la découverte des vers adultes à la surface des selles ;

Par la mise en évidence des œufs

embryonnés

par le test de Graham (scotch- test) qui a pour but de décoller les œufs de la marge anale.

Rarement par la mise en œuvre de quelques œufs dans un examen de selle

.

COMPLICATIONS

Digestives:

appendicite à oxyure.

Gynécologiques:

vulvites-vulvo-vaginites, salpingite chez la petite fille. Psychiques: baisse du rendement scolaire, insomnie.

Diapositive 154

TRAITEMENT

Zentel

:

Posologie

1

cp

en 1 prise unique quelque soit l'âge mais pas avant 2 ans.

OU

flacon

en 1 prise unique.

Pamoate

de

pyrentel

(

combantrin

):

Posologie

: 10 mg/kg/j en 1 prise

appliquer

les règles d'hygiène classique (mains lavées avant chaque repas, ongles coupés courts).

répéter la cure d'

oxyuricide

10 à 15 jours plus tard

Diapositive 155

PROPHYLAXIE

Pour éviter la contamination des sujets sains et l'auto infestation, il est nécessaire de : traiter simultanément tous les membres de la famille ou de la collectivité (qu'ils soient parasités ou suspectés de l'être) appliquer les règles d'hygiènes classiques (mains lavées avant chaque repas, ongles coupées court, vêtements et literie lavés et changer régulièrement)

porter aux enfants des « culottes serrées » pour les empêcher de se gratter

utiliser toujours des latrines

répéter la cure d'

oxyuricide

au moins tous les 6 mois.

Diapositive 156

RECAP: MODE DE CONTAMINATION

ASCARIS = INGESTION

ANKYLOSTOME = VOIE CUTANEE

ANGUILLULE = VOIE CUTANEE

OXYURE = INGESTION

Diapositive 157

LES CESTODOSES

Les

cestodoses

sont des helminthiases liées à la présence dans l'intestin de l'homme de vers plats ou cestodes

, qui se présentent sous forme larvaire ou sous forme adulte.

Diapositive 158

TENIASE A TAENIA SAGINATA

C'est le ténia du bœuf ; il mesure 4 à 12 m de long. Son scolex (tête) piriforme de la taille d'une tête d'épingle porte 4 ventouses grâce auxquelles, il se fixe sur la muqueuse intestinale ; elle est dépourvue de crochets (ténia inerme). Le cou est étroit et ne mesure que quelques millimètres. Le corps est formé d'environ 2000 anneaux

.

Diapositive 159

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 160

De son strobile (corps) se détachent 5 à 10 anneaux par jour qui sortent avec les selles, mais de façon spontanée par des mouvements actifs, en forçant le sphincter anal, les anneaux peuvent se retrouver dans les vêtements et dans la literie.

Diapositive 161

MODE DE CONTAMINATION-CYCLE BIOLOGIQUE

Dans le milieu extérieur, les anneaux d'abord mobiles animés de mouvements de reptation finissent par se dessécher et se désintègrent libérant des milliers d'œufs (embryophores

) en moyenne 80 000 œufs/anneau. Ingérés par un hôte intermédiaire réceptif (bœuf), la coque de l'œuf est dissoute par les sucs digestifs et l'embryon muni de 06 crochets (embryon hexacanthé) est libéré.

Diapositive 162

Il va alors traverser la paroi intestinale et migrer par voie lymphatique ou sanguine vers les tissus adipeux qui entourent les muscles pour se transformer en larves dites cysticerque au bout de 3 à 4 semaines. L'homme s'infecte en mangeant de la viande de bœuf crue ou insuffisamment cuite. Dans l'intestin, le cysticerque se fixe par ses ventouses à la muqueuse et se met à bourgeonner des anneaux. Le ténia devient adulte en 3 à 4 mois aux termes desquels les anneaux distaux commencent à se détacher.

Diapositive 163

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Le plus souvent, l'infestation est totalement latente et n'est révélée que par la découverte des anneaux dans le linge ou la literie. Par ailleurs, l'on note:

les troubles digestifs vagues tels que : douleurs abdominales ou épigastriques, nausées ou vomissements, anorexie ou boulimie, diarrhée ou constipation,

les troubles généraux tels que: amaigrissement-asthénie,

les troubles neurovégétatifs : dyspnée-palpitations.

Diapositive 164

DIAGNOSTIC

Une hyper éosinophilie sanguine modérée 500 à 1000/mm en moyenne

Le lavement baryté pratiqué devant des douleurs épigastriques, troubles du transit

, permet

de voir l'image du ténia sous forme de bandelettes longues continues de 1 à 3 mm d'épaisseur (si les anneaux sont parallèles aux rayons X),

Présence d'anneaux dans le linge et la literie,

Mise en évidence des œufs collés à la marge anale par le test de GRAHAM

.

Diapositive 165

TRAITEMENT

Niclosamide

(

trédemine

)

comprimés à 500 mg

Posologie:

2

cp

à jeun

à mâcher, attendre

une heure toujours à

jeun,

Prendre

2

cp

comme

précédemment,

a

attendre

3 heures avant de se réalimenter,

Dans certains cas, on peut introduire le produit par tubage duodénal au contact du ver.

NB

:

la

Trédemine

peut être administré sans danger chez la femme enceinte

.

Praziquantel

(

Biltricide

)

Posologie

: 10 mg/kg en 1 prise sans précaution de jeûne. Efficacité proche de 100%.

Diapositive 166

PROPHYLAXIE

Mesures générales

Mesures visant à empêcher l'infestation de l'hôte intermédiaire

traitement de tous les porteurs de ténia,

construction et utilisation des latrines,

stabulation des animaux,

traitement des eaux usées.

Mesures visant à empêcher l'infestation de l'homme

surveillance vétérinaire de la viande

assainissement de la viande par congélation, vaccination à l'étude

.

Mesures individuées

Cuisson suffisante de la viande de bœuf

Diapositive 167

TENIASE A TAENIA SOLIUM

Taenia

solium

est

le tænia du porc. C'est un ver plat de 2 à 8 mètres de long qui comporte 1000 anneaux. Son scolex possède une petite saillie rétractile appelée rostre armée d'une double couronne de crochets « tænia armé ». Il vit dans l'intestin grêle de l'homme. De son

strobile (chaîne d'anneaux)

se détachent des anneaux murs par groupe de 5 à 10 et sont éliminés passivement dans les selles.

Diapositive 168

MODE DE CONTAMINATION-CYCLE BIOLOGIQUE

Dans le milieu extérieur, les anneaux et les œufs répandus sur le sol sont avalés par le porc. Dans son tube digestif, l'embryon hexacanthé est libéré et gagne le tissu musculaire (cœur, langue) où il se transforme en larve cysticerque appelée

cysticercus

cellulosae

.

Ce cysticerque ingéré par l'homme avec de la viande de porc mal cuite s'attache à la paroi de l'iléon et grossit pour devenir adulte en 3 mois. Des anneaux vont alors se détacher et être éliminés dans les selles.

Diapositive 169

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Voir

Taeniasose

à

taeniasaginata

.

DIAGNOSTIC

Mise en évidence d'

embryophores

au niveau de la marge anale par le scotch test de GRAHAM

.

TRAITEMENT

Voir

taeniasose

à

taeniasaginata

.

PROPHYLAXIE

Voir

Teniasose

A

TaeniaSaginator

Diapositive 170

TENIAE A DIPHYLLOBOTRIUM LATUM OU BOTHRIOCEPHALES

C'est le plus grand des cestodes adultes puisque sa taille moyenne est de 2 à 8 m pouvant atteindre 20 mètres. Son scolex est ovoïde et présente 2 ventouses allongées. Son strobile est formé de 3000 à 4000

anneaux contenant

à maturité au centre un utérus polylobe.

Contrairement aux autres ténias, il possède un orifice de ponte. Il n'est pas strictement inféodé à l'homme mais parasite également de nombreux animaux (chiens, chat, ours).

Diapositive 171

diphyllobotrium

Diapositive 172

MODE DE CONTAMINATION & CYCLE BIOLOGIQUE

Les vers adultes pondent des œufs non
embryonnés

qui sont éliminés dans les selles.

Il se

forme en embryon en 10 à 15 jours. L'œuf éclot et libère une larve:

corracidium

. Nageant dans l'eau, le

corracidium

est avalé par un crustacé (cyclops) où il va se transformer au bout de 15 jours en larve
procercoïde

.

Si le cyclops est avalé par un poisson, la larve

procercoïde

va traverser le tube digestif, migrer dans tout l'organisme, se transformer en larve

plerocercarioïde

qui est la forme

infestante

pour l'homme et certains

mammifères.

C'est en ingérant l'un de ces poissons que l'homme ou divers mammifères contractent la
bothriocéphalose

.

Diapositive 173

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Le bothriocéphale détermine les troubles habituels de la téniasse

; il engendre parfois une anémie macrocytaire et mégaloblastique (attribuée à l'avidité du ver pour la vitamine B12 à l'intérieur du tube digestif qui réaliserait une carence d'apport

.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic repose sur la découverte d'œufs dans les selles brunâtres, opercules, non embryonnés

.

TRAITEMENT

Traitement spécifique du parasite :

Niclosamide

(

Tredenine

)

Traitement d'anémie : Vitamine B 12

.

Diapositive 174

PROPHYLAXIE

Cuisson suffisante du poisson ou autres
mammifères

AUTRES TAENIASES

D'autres

taeniasés

peuvent être observés:

taeniasé

à

hymenolepis

Nana

taeniasé

à

hymenolepis

Diminuta

(contamination accidentelle d'un arthropode)

taeniasé

à

Dipylidium

Caninum

(indigestion de puce provenant du chien-chat).

Diapositive 175

RECAP

TAENIASES:

INGESTION A PARTIR DE LA VIANDE DE L'HOTE

SAGINATA = VIANDE DE BŒUF

ANNEAUX DETACHABLES AVEC LES OEUFS

UNIQUEMENT HUMAIN

SOLIUM = VIANDE PORC

ANNEAUX DETACHABLES AVEC LES OEUFS

UNIQUEMENT HUMAIN

BOTRICEPHALE = POISSON

ANNEAUX NON DETACHABLES

POSSEDE UN ORIFICE DE PONTE

DEUX HOTES

PEUT PARASITER D'AUTRES MAMIFERES

Diapositive 176

FILARIOSE

On regroupe sous le nom de filarioses un ensemble de maladies causées par des parasites nommés filaires. Ces parasites provoquent chez l'homme des signes cliniques qui se manifestent généralement au niveau de la peau, du système lymphatique (ganglion) et de l'œil; elles évoluent lentement et sont rarement mortelles. Mais elles peuvent devenir graves en raison de l'incapacité fonctionnelle qu'elles créent: abcès de la jambe ou du pied, perte progressive de la vision etc.

Les principales filarioses humaines sont: la filariose lymphatique (

wuchereriabancrofti

), la filariose sous-cutanée ou base (

loa-loa

), l'onchocercose (

onchocerca

volvulus) et enfin la dracunculose (

dracunculusmedinensis

).

Diapositive 177

DRACUNCULOSE

La dracunculose est une filariose due à un ver filiforme appelé
dracunculus
medinensis
qui se localise généralement dans le derme.

La

dracunculose se rencontre dans toutes les régions chaudes du monde. En Afrique, elle occupe toute la région tropicale et la vallée du Nil

.

Dracunculus

medinensis

est l'agent pathogène. La femelle mesure environ 80 à 100 cm

.

Diapositive 178

DRACUNCULUS MEDINENSIS

Diapositive 179

Réservoir de

germe

est

constitué uniquement de l'homme malade.

L'hôte

intermédiaire est un crustacé appelé

coronatus

qui vit dans les eaux douces dormantes et stagnantes.

Les localisations fréquentes du ver sont les membres inférieurs (98%) mais on peut retrouver le ver au niveau des organes génitaux, le creux axillaire, la langue

Diapositive 180

CYCLE PARASITAIRE

La filaire femelle adulte qui vit en général dans le derme au contact de l'eau se rapproche de la peau par son extrémité utérine pour libérer les larves.

Les larves expulsées par la femelle poursuivent leur développement une fois ingéré par le cyclops pour devenir infestant après 3 semaines d'évolution

.

Diapositive 181

L'homme se contamine buvant de l'eau contenant les cyclops qui vont être dissous par les sucs gastriques

. Les

vers adultes libérés traversent la paroi du tube digestif pour atteindre les tissus. Les vers mâles meurent après fécondation avec la femelle. La femelle vient se placer sous la peau au niveau des membres inférieurs.

Ainsi, au contact de l'eau, la femelle libère plusieurs milliers de larves et le cycle recommence.

Diapositive 182

ETUDE CLINIQUE

Période

d'incubation

est

asymptomatique et dure environ un an

.

Période

d'invasion

est marquée par

une

poussée

urticarienne

(démangeaison) précédant la sortie du

ver,

un

pseudo-phlegmon

fistulisé

de la jambe laissant apparaître l'extrémité du

ver et des

troubles digestifs : nausées ou vomissements ou

diarrhée.

Période

d'état : phase

importante

est

caractérisée par une impotence fonctionnelle de 2 à 3 semaines correspondant à l'expulsion totale du ver ou des vers en l'absence de toutes

complications.

Diapositive 183

COMPLICATIONS

Elles font tout l'intérêt de la maladie et elles sont constituées par :

infectieuses:

tétanos, abcès, gangrène, septicémie, etc.

séquelles:

ankylose articulaire, rétraction tendineuse

.

Le

diagnostic positif repose uniquement sur la mise en évidence du ver adulte par la vision.

NB

:

Les adultes ou les embryons ne se recherchent pas dans les selles, ni dans le sang encore moins dans les urines.

Diapositive 184

TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE

L'extirpation du ver de façon mécanique par enroulement progressif (1 tour/ jour) autour d'une allumette ou d'un bâtonnet, sans le casser demeure le

moyen le

plus efficace de supprimer le parasite mais elle est lente (2 à 3 semaines) et délicate.

Antibiothérapie et renouvellement journalier du pansement

.

La prophylaxie consiste à

i

soler

et traiter les maladies

identifiées; instaurer

une communication pour le changement de comportement avec les malades et les communautés :

Diapositive 185

Demander aux

malades de s'abstenir de mettre les pieds dans l'eau, construire des puits avec margelle

,

conseiller aux populations de boire de l'eau potable

.

Enseigner les

procédés de potabilisation de l'eau à domicile :

Filtration: très efficace avec un simple pagne ou tissu propre

Ebullition de l'eau

Désinfection chimique : javellisation

Procéder à la destruction des cyclops dans toutes les zones identifiées.

Assurer

une surveillance épidémiologie accrue dans les zones d'endémie.

Diapositive 186

L'ONCHOCERCOSE

ou

la

cécité des

rivières

L'onchocercose est une filariose provoquée par l'infestation de la peau et des yeux par un ver nématode,

onchocerca

volvulus

.

L'onchocercose

est surtout répandu dans de nombreux pays d'Afrique intertropicale comme le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, l'Ouganda, le Zaïre et constitue l'une des principales causes de cécité. Il existe par ailleurs quelques foyers en Amérique Centrale

.

L'agent

pathogène est

onchocerca

volvulus.

Diapositive 187

Le

vecteur qui est l'hôte intermédiaire est la simule ou
simuliumdamnosum

. Elle se rencontre le plus souvent le long des fleuves et des rivières aux courants rapides favorables
à la ponte et aux développements des œufs

.

La

transmission se fait essentiellement par la piqure de la simule.

Diapositive 188

CYCLE PARASITAIRE

La femelle pond ses œufs dans les eaux courantes sur les objets émergents (herbes, branches). Une dizaine de jours plus tard, après être passés les stades larvaires, puis nymphe, les jeunes adultes (simulie) s'envolent.

A l'occasion d'une piqûre sur un sujet infecté, la simulie absorbe les microfilaires (embryons de ver). Après plusieurs mues, celles-ci deviennent

infestantes

.

Dès lors, elles peuvent être inoculées à un individu sain, chez qui elles achèveront leur croissance pour donner des filaires mâles et femelles.

Diapositive 189

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 190

ETUDE CLINIQUE

L'incubation

est

silencieuse et dure entre : 3- 6

mois et dominée

essentiellement par des manifestations cutanées :

Onchocercomes

ou kystes

onchocerquiens

: qui sont des nodules fermes, mobiles sous la peau, de taille très variable, unique ou multiples. Ces kystes siègent généralement au niveau du grand trochanter; du gril costal ; des crêtes iliaques chez l'adulte ; et particulièrement chez l'enfant et l'adolescent au niveau de la tête.

Diapositive 191

Prurits

onchocerquiens

ou gale

filarienne

: il s'agit de lésions très prurigineuses de la peau; qui siègent au niveau des fesses, des cuisses, aux avant-bras et au thorax. Elles s'accompagnent d'une pachydermie

.

La Période d'état

est

dominée par les troubles oculaires tardifs progressifs, bilatéraux et irréversibles car les yeux sont atteints dans tous les segments (cornée - iris - rétine), entraînant à la longue une cécité

.

Diapositive 192

Signes cliniques annonciateurs

Penser à l'onchocercose chez tout patient en zone d'endémie

onchocerquienne

se plaignant soit de :

troubles oculaires : héméralopie ou d'une baisse de l'acuité visuelle, de douleurs oculaires et larmoiement

un ou plusieurs nodules prurit généralisé et persistant

Diapositive 193

Examens précliniques

La biopsie cutanée exsangue permet de :

confirmer le diagnostic par la découverte des microfilaires

apprécier l'importance de l'infestation (charge parasitaire)

charge faible : 0-10 microfilaires

charge moyenne: 11-50 microfilaires

charge forte : > 50 microfilaires.

Diapositive 194

TRAITEMENT

Traitement

médical

repose à l'heure actuelle sur un médicament très puissant et qui vise à stériliser l'organisme du malade en détruisant les microfilaires et les vers adultes

.

IVERMECTINE

cp

=

6mg

à la

Posologie de

15-24 kg = 3 mg soit ½

cp

en 1 prise unique 25-44 kg = 6 mg soit 1

cp

en 1 prise unique

Traitement

chirurgical

Dans

la destruction des vers adultes, l'on pratique dans certains cas une nodulectomie

(extirpation chirurgicale des kystes ou nodules). Cette opération est sans danger, mais elle est insuffisante car elle n'atteint qu'un nombre assez faible de

filaires

Diapositive 195

PROPHYLAXIE

L'OMS a mis en place un dispositif qui associe la lutte contre les simuliés, le traitement des populations atteintes à un programme de recherches scientifiques. Ce programme fait l'objet de campagne de l'OMS depuis 1974 dans sept pays d'Afrique de l'Ouest touchés par ce fléau (y compris la C-I). Il consiste en

:

Diapositive 196

un dépistage précoce et un traitement des cas identifiés ;

une sensibilisation des populations sur la nécessité de se protéger contre les piqûres de simule par le port de vêtement approprié, par l'utilisation de produits répulsifs

et la

destruction des foyers de reproduction et des mouches tsé-tsé par la pulvérisation aérienne ou au sol d'insecticide (ex: DDT) et par l'utilisation de piège à glossine ;

Diapositive 197

RECAP

DRACUNCULOSE:

AGENT PATHOGENE = DRACUNCULUS MEDINENSIS

MODE DE TRANSMISSION = INGESTION DE

CYCLOPS

PAR EAU DE BOISSON

VER VISIBLE A L'ŒIL NU MAIS JAMAIS DANS LES SELLES

ONCHOCERCOSE

AGENT PATHOGENE = ONCHOCERCA VOLVULUS

VECTEUR = SIMULIE

MODE DE TRANSMISSION = PIQURE DE LA SIMULIE